

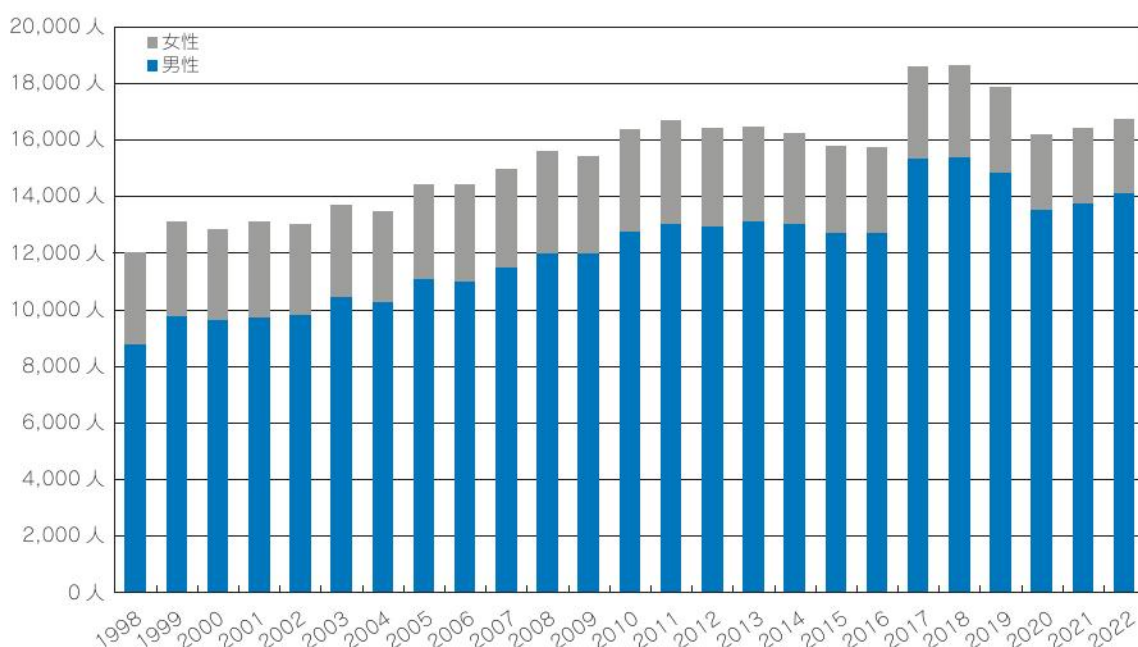


図1 わが国における COPD 死数の推移
[GOLD 日本委員会：COPD データ集より引用]

しかし、喘息死亡統計が実態を正確に反映しているかについては、注意が必要である。沖縄県での経験では喘息死は高齢者であることが多く、実際に重症喘息として救急外来を受診する症例とは明らかに年齢分布の異なることが報告されている⁷⁾。また香川県において、死亡診断書の解析から、喘息死の統計の中に、本来の喘息死ではない症例が紛れ込んでいる可能性が報告されている⁸⁾。すなわち日本の喘息死統計には、その他の疾患が含まれる可能性がある。たとえば喘鳴を伴う疾患としては、慢性閉塞性肺疾患 (COPD)、うっ血性心不全、あるいは喘息様気管支炎と称されるような誤嚥性肺炎が含まれている可能性がある^{7), 8)}。

特に高齢者においては、喘息死と診断する際に、喘息様気管支炎と称されるような呼吸器感染症、COPD、またはうっ血性心不全の可能性を考慮に入れる必要がある。また喘息死が2,000名を切った現在、改めて喘息死と診断された症例の背景因子を詳細に検討することが求められる。

4 増加してきた COPD 死

一方、喘息死と比較して、日本における COPD による死亡者数は、長期的に増加傾向を示しており (図1)⁹⁾、厚生労働省の「人口動態統計」によれば2022年の COPD による死亡者数は16,676人 (男性14,019人、女性2,657人)、10万人あたりの死亡率は13.7人 (男性23.6人、女性4.2人) である。COPD による死亡者数は増加傾向がみられるものの、現在、喫煙率が急速に低下していること、多くのたばこにはフィル

ターが装着されていること、また以前に比して職業上の粉じん被曝の頻度が低下していることなどから、COPD の死亡者数は今後減少傾向になることも期待される。また COPD の総患者数は、2020 年時点で治療を受けている患者数は36万2,000人 (男性26万2,000人、女性10万人) と報告されている¹⁰⁾が、早期診断や啓発活動の強化により、今後無症状の早期 COPD 患者が増加する可能性がある。特に、CT 検診などで発見される無症状の早期 COPD 例に対して、薬物治療の必要性を慎重に判断することが求められる。

5 増加してきた肺癌死

表1、図2で示されるごとく肺癌の総患者数、および死亡者数は増加傾向にある。一般病院で勤務する呼吸器科医にとって実感する特に大きな変化は、肺扁平上皮癌 (特に肺門部発生) の急激な減少と、肺腺癌の増加である。これらの変化の要因は、COPD で記載した因子 (特に喫煙率の推移) と関連しているのかもしれない。また喫煙との関連性が乏しいと考えられている女性の腺癌の病態解明、および治療法の進歩、および免疫チェックポイント阻害薬の導入により、肺癌死は今後減少することが期待される。

6 今後の呼吸器科医の役割について

日本は、世界でも長い平均寿命を有する国のひとつである。今後のさらなる健康増進のためには、効率的な健康政策を行う必要がある。さて呼吸器科医とし